

考试 | 22 年消化系统模块（八年制）

简答题*3

黄疸的病因学分型和典型疾病

胃癌的内外科治疗（题干是英文）

① 内镜治疗：直径小于 2cm 的无溃疡表现的分化型黏膜内癌，可行内镜下黏膜切除术或内镜黏膜下剥离术。

② 手术治疗：

根治性手术：标准术式 D2 淋巴结清扫的胃切除术，切除胃的 2/3 以上，距离肿瘤边缘至少 5cm。

姑息性手术：原发灶无法切除，针对并发症进行手术。

③ 化疗：对于不可切除性、复发性、姑息性手术后的胃癌晚期病人，常用药物 5-FU、丝裂霉素、多柔比星、顺铂。

④ 其他：放疗不敏感，靶向治疗包括曲妥珠单抗（HER-2）、贝伐珠单抗（抗 VEGFR）、西妥昔单抗（抗 EGFR）

内科 P381

门静脉高压侧支循环和并发症 P419

食管静脉曲张、胃底静脉曲张、腹壁静脉曲张、痔静脉曲张、腹膜后吻合支曲张、脾肾分流
并发症--肝性脑病，食管胃底静脉曲张破裂出血（肝硬化最常见并发症）

病例分析题*1

既往胆囊炎合并胆囊结石行胆囊切除术患者，男性，62 岁，黄疸，寒战高热，右上腹进行性绞痛，腹部 B 超提示胆总管扩张合并胆总管结石

- （1）考虑疾病
- （2）确诊依据
- （3）鉴别诊断
- （4）进一步检查
- （5）治疗原则

选择题

结直肠癌 dukes 分期

球后溃疡

门静脉高压紧急处理

三腔两囊管止血

胃癌转移

消化最强的消化液

氨在脑内主要去路

胃恶性溃疡最重要临床表现

胃食管反流最常见于哪个部位

溃疡性结肠炎最常见并发症

克罗恩病 鹅卵石症 最常见并发症

结核性腹膜炎诊断

结直肠癌最主要临床表现

急性胰腺炎首选诊断

肠结核复查最常用检查

根除幽门螺杆菌四联用药

肛裂常见部位

直肠指检常见体位

肛周脓肿形成原因

肝内窦前性梗阻常见病因

克罗恩病和肠结核 非干酪样

肝蒂内不包括什么结构

胃癌癌前病变

减少假神经递质药物

中毒性巨结肠

先天性巨结肠

食管癌常见部位

十二指肠球后溃疡特征

移动性浊音提示腹水

上消化道出血量和对应数值（黑便、呕血等等）

考试 | 21 年消化系统整合模块（八年制）

题型：

100 道选择 A1A2A3 都有

3 道简答题

1 道病例分析

考试范围看贺银成差不多,也要多看 PPT 内容,有一些内容没啥印象的也考到了,生化这部分也要好好看看(虽然不应该出现在这)
and 假期愉快啦大家~

选择题部分:

生化:

糖异生途径(在肝的线粒体及胞液中进行)

唯一在肝脏代谢的物质(尿素)

梗阻性黄疸皮肤瘙痒是什么物质的作用

胃液分析

药理:

药物利用度的定义

生理:

对平滑肌收缩节律起决定性作用的波,起自于哪里

消化道内在神经丛包括

胃粘膜不被胃酸侵蚀的原因

维生素 B12 缺乏是因为胃部哪个细胞减少

紧张性收缩

消化蛋白质最强的酶

内科:

消化系统疾病诊治要关注什么(英文 应该是病史)

亚硝酸盐中毒表现—皮肤粘膜发绀—高铁血红蛋白含量增加

CO 中毒表现

急性中毒 COHb 可达 5%-10%

皮肤粘膜呈樱桃红色,呼吸困难、昏迷

磷中毒的治疗用药

胆碱酯酶复活药--首选解毒药:氯解磷定,次选碘解磷定,对抗 N 胆碱受体活性,可以有效解除烟碱样毒性作用(肌肉震颤);阿托品,为 M 受体阻断剂,可有效解除 M 样症状(瞳孔缩小、大汗、流涎)

急性有机磷杀虫药中毒是指 OPI 进入体内抑制乙酰胆碱酯酶活性,引起体内生理效应部位 ACh 大量蓄积,出现毒蕈碱样、烟碱样和中枢神经系统等中毒症状和体征,患者常死于呼吸衰竭。

酗酒患者出现步态不稳等表现(Wernicke 脑病)

胃食管反流病临床表现

食管症状--典型--烧心(剑突下烧灼感)和反流(餐后 1 小时内),卧位、弯腰或腹内压增高可加重

--非典型--反流物刺激食管引起胸痛、吞咽困难、胸骨后疼痛

食管外症状--1. 慢性咳嗽、咽喉炎、哮喘，严重出现吸入性肺炎/2. 癔球症：咽部不适、异物感、棉团感，无真正吞咽困难

Barrett 溃疡发生部位（英文）

Barrett 溃疡是在 Barrett 食管基础上形成的溃疡，后者为食管粘膜严重损伤所导致，有恶变为腺癌的倾向。

慢性胃炎最常见的病因--Hp 感染

A 型胃炎病因--自身免疫型胃炎、慢性胃体炎

B 型胃炎病理特点--多灶萎缩性胃炎、慢性胃窦炎

--粘膜色泽变淡，皱襞变细而平坦、粘膜下血管透见，胃粘膜呈颗粒状或结节状

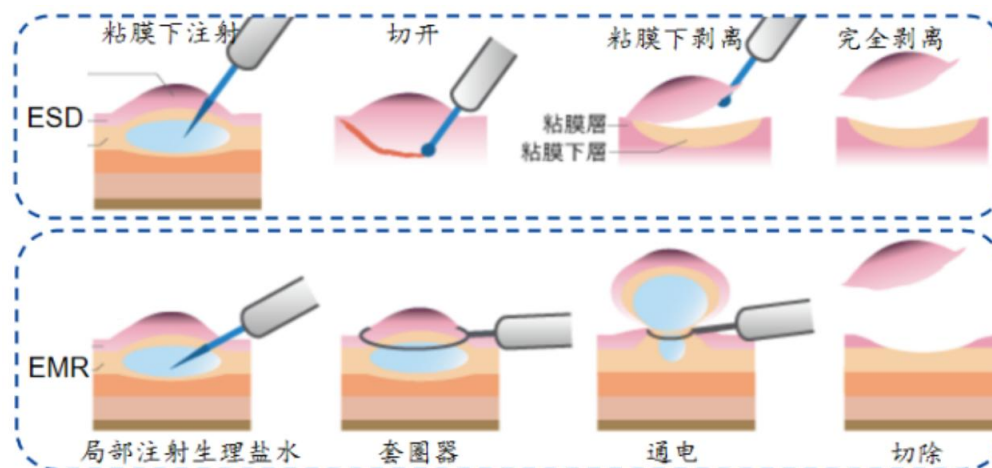
抗幽门螺杆菌治疗方案--两种抗生素--PPI--铋剂

能形成胃肠保护膜的药物（硫糖铝）

十二指肠溃疡好发部位--十二指肠球部前壁/后壁

促胃液素瘤（Zollinger-Ellison 综合征）的检查指标--血胃泌素水平

--这是一种胃、肠、胰神经内分泌肿瘤



肠易激综合征排除器质性疾病用结肠镜

肠结核好发于哪里--回盲部

粘液脓血便常见于哪个疾病--菌痢/溃疡性结肠炎

溃疡性结肠炎溃疡浅、粘膜弥漫性充血水肿、颗粒状、脆性增加

UC 并发症中毒性巨结肠

重症病人累及结肠壁全层--肠壁重度充血、肠腔膨大、肠壁变薄，当溃疡累及肌层至浆膜层，可致急性穿孔

约 5%重症病人可出现中毒性巨结肠--结肠蠕动消失，气液积聚，横结肠最为严重，出现肠型，肠鸣音消失，毒血症明显

癌变（病程长），大出血（见于中毒巨结肠；肠梗阻少见）

UC 轻症患者治疗用药--氨基水杨酸和柳氮磺吡啶

控释剂--美沙拉嗪

糖皮质激素--中度、重度病人治疗首选

口服泼尼松--结肠、小肠；针推--氢化可的松--结肠、大肠；灌肠--布地奈德--直肠、全身不良反应少

克罗恩病特征性临床表现--腹泻、腹痛、体重下降，发热、疲乏

肛周病变可为本病首发症状，瘘管形成，腹部包块

全身表现：发热、营养障碍

肠外表现--口腔黏膜溃疡、皮肤结节性红斑、关节炎及眼病

并发症--最常见--肠梗阻，腹腔脓肿、肠急性穿孔，炎症迁延不愈者癌变风险增加

我国肝硬化最常见病因--HBV

蜘蛛痣原因--雌激素增多

门静脉高压

肝硬化门脉高压首先出现的体征是脾大（对诊断肝硬化门脉高压症最有价值的体征是食管胃底静脉曲张，老二是腹壁静脉曲张）

肝硬化失代偿期最突出的临床表现是腹腔积液

腹腔积液机制最重要的是门脉高压导致静水压增高

自发性腹膜炎措施--诊断性腹腔穿刺--**静脉注射头孢曲松或头孢噻肟等抗生素**

腹膜炎时不可以镇痛治疗

原发性肝癌先转移到哪--肝内转移，然后通过血道途径转移到门脉和肺

肝硬化最严重的并发症--肝性脑病

外科：

内环外环解剖位置

koolearn
新东方在线

一、腹股沟区解剖

- **内环**：精索或子宫圆韧带穿过腹横筋膜而形成的一个卵圆形裂隙
- **外环**：腹外斜肌腱膜纤维在耻骨结节上外方形成的一个三角形裂隙
- **前壁**：腹外斜肌腱膜。
- **后壁**：外2/3腹横筋膜，内1/3联合腱。
- **上壁**：腹内斜肌和腹横肌形成的弓状下缘。
- **下壁**：腹股沟韧带和腔隙韧带
- **内容物**：精索或子宫圆韧带



关注微信公众号：有胸学社

绞窄疝嵌顿疝区别

嵌顿疝如果不及时解除肠管及其系膜在受压的情况下很容易出现绞窄，不断加重可能使得肠管动脉血流完全阻断。术中探查的嵌顿可以恢复，但是绞窄不能恢复

腹部损伤脾破裂

急性化脓性腹膜炎腹腔穿刺意义--

结核性腹膜炎为草绿色透明腹水

胃十二指肠急性穿孔抽出液呈黄色，浑浊、含胆汁、无臭味，饱食后穿孔抽出液有食物残渣；

急性重症胰腺炎抽出液为血性、淀粉酶高；

急性阑尾炎穿孔时抽出液为稀薄脓性，略有臭味；

绞窄性肠梗阻抽出液为血性、臭味重；

抽出不凝血--腹腔出血

抽出液可以进行细菌培养

急性胃十二指肠溃疡穿孔的体征--

腹部压痛、反跳痛和腹肌紧张是腹膜炎的典型体征，胃肠穿孔的时候甚至可以引起强烈的腹肌紧张，甚至“木板样”强直

胃十二指肠溃疡急性穿孔，内容物流入腹腔产生化学性刺激，诱发化学性腹膜炎，继而成为化脓性腹膜炎

高选择性迷走神经切断术保留了胃窦的鸦爪支

--胃窦处由胃前、后支吻合而成

残胃癌好发于胃大部切除术后 15 年以后

--胃大部切除术后残胃黏膜发生慢性炎症改变，可能在术后 15-25 年发展为残胃癌

胃癌转移肝最常见

胃癌手术前温热蒸馏水冲洗的原因

抑制术中脱落的胃癌细胞的生长活力，减小其增殖的可能，从而避免胃癌细胞种植播散导致的术后肿瘤复发

胃癌腹膜种植到卵巢 Krukenberg 瘤

嵌顿性肠梗阻和绞窄性肠梗阻的差别

肠梗阻临床表现:痛吐胀闭

阑尾炎主要体征--

结肠癌最早出现的症状--排便习惯的改变

直肠癌的症状体征:里急后重等

进行性排便困难疑诊--直肠癌

Dixon 手术指征--

肿瘤切缘至少 2cm，低位直肠癌至少 1cm；肛管外括约肌和肛提肌未受累，且无肛门失禁

哪个器官栓塞不会梗死—肝脏

血供供应较丰富

门静脉高压类型:肝前肝内肝后

肝前（肝外门静脉血栓形成）、先天畸形和外在压迫

肝内--血吸虫病（窦前）、肝炎肝硬化、门静脉-肝动脉交通支的开放

肝后--缩窄性心包炎、严重右心衰竭

胆囊动脉起自于肝右动脉

Vater 壶腹的构成

胆总管和主胰管在肠壁内汇合

胆囊三角构成

肝总管、胆囊管、肝的脏面

放置 T 管适应症

胆总管切开取石、T 管引流术--适用于单纯胆总管结石，胆囊上下端通畅，无狭窄或其他病变者。

（1）引流胆汁。（2）引流残余结石，尤其是泥沙样结石；术后亦可经 T 管溶石、造影等。（3）支撑胆道：避免术后胆总管切口瘢痕狭窄、管腔变小、黏连狭窄等。

AOSC 的紧急处理—急性梗阻性化脓性胆管炎

立即解除胆道梗阻并引流

--胆总管切开引流 T 管

--ENBD--内镜鼻胆管引流术

--PTCD--经皮肝穿--高位胆管或非结石性梗阻效果较好

肝外胆管结石的手术治疗

--胆总管切开取石、T 管引流术（10-14 天 T 管引流、胆道通畅开腹手术可以 4 周拔掉 T 管）如果造影发现有结石遗留，应该在手术后 4-8 周左右待 T 管旁纤维窦道形成后再施行胆道镜检查 and 取石术

--胆肠吻合术--Roux-en-Y

适应症--胆总管远端炎症狭窄造成的梗阻无法解除，胆总管扩张；胆胰管汇合部异常，胰液直接流入胆管；胆管因为病变而部分切除，无法再吻合--胆囊已不能发挥其功能，故应同时切除，没有 oddi 括约肌的功能

夏科三联征—上腹部疼痛、寒战高热及黄疸

胆囊无痛性肿大（Courvoisier 征）好发于什么类型—胆管癌

急性胰腺炎发作 8 小时急查什么指标—血清淀粉酶

急性胰腺炎没有参考价值的指标（英文）

有价值--白细胞计数、高血糖、肝功能异常、低血钙、酸中毒

CRP 反应蛋白增高提示病情较重

急性胰腺炎与血管出血直接相关的酶—胰蛋白酶

急性胰腺炎的并发症（英文 假性囊肿 pancreatic pseudocyst, PPC）

胰岛素瘤发作于胰岛 B 细胞

出现黑便估计出血量多少——50ml

急腹症的诊断

简答题：

简述溃疡性结肠炎（UC）与克罗恩病（CD）的区别。

（1）症状：溃疡性结肠炎腹痛多为左下腹轻压痛，多见脓血便，有里急后重感，便后腹痛缓解，有时可触及痉挛的降结肠或乙状结肠，腹肌紧张、反跳痛时警惕并发中毒性巨结肠；

克罗恩病腹痛、腹部包块多位于右下腹或脐周，腹泻粪便多为糊状，但少见粘液脓血便；常见且特异的临床表现为瘻管形成与肛周病变。

（2）病变分布：

溃疡性结肠炎从直肠开始，病变逆行向结肠近端发展，可累及全结肠甚至末端回肠；克罗恩病累及全消化道，但以末端回肠及邻近结肠最为多见；病变分布前者呈连续性，后者呈阶段性。

（3）直肠受累：

UC 多数直肠受累，结肠 CD 少见直肠受累

（4）肠腔狭窄：前者少见肠腔狭窄，后者多见

（5）溃疡及黏膜：UC 溃疡浅、黏膜弥漫性充血水肿、颗粒状，脆性增加；克罗恩病纵行溃疡，黏膜呈鹅卵石样，病变间的黏膜正常

（6）组织病理：UC 固有膜全层弥漫性炎症、隐窝脓肿、隐窝结构明显异常、杯状细胞明显异常并减少；CD 非干酪样肉芽肿、裂隙状溃疡、黏膜下层淋巴细胞聚集

简述肝硬化导致门脉高压后产生的侧支循环有哪些。

主要有食管静脉丛、直肠静脉丛、脐周静脉丛。

（1）胃左--食管--奇静脉--上腔静脉

（2）肝门--脾静脉--肠系膜下静脉--直肠上静脉--直肠静脉丛--直肠下静脉--髂内静脉--髂总静脉--下腔静脉

（3）肝门静脉--腹脐静脉--脐周静脉网--

1°--上行--腹壁浅静脉--胸壁浅/深静脉--腋静脉/锁骨下静脉--上腔静脉

2°--下行--腹壁 a) 浅静脉--大隐静脉--股静脉

b) 深静脉--髂外静脉--髂总静脉--下腔静脉

简述 Reynolds 五联征见于什么疾病?有什么表现。

见于急性梗阻性化脓性胆管炎。腹痛，寒战高热，黄疸之外还有休克、中枢神经系统受抑制表现，成为 Reynolds 五联征。

病例分析题：

十二指肠溃疡合并出血的病例

（1）诊断是什么

（2）与什么疾病鉴别诊断，写出疾病名称

（3）还需要做什么检查

(4) 治疗原则和措施